

Plan *kryzysowy*

Dokument, który piszesz teraz, w eutymii — dla siebie w epizodzie. Trzy poziomy nasilenia, konkretne kontakty, konkretne decyzje. Bez wątpliwości w środku kryzysu.

CZAS: 60 min — wypełnienie z bliskimi Aktualizacja co 6 miesięcy

ŹRÓDŁO: Bauer i wsp. (1998); Sajatovic i wsp. (2009)

JAK UŻYWAĆ

Wypełnij ten plan z osobą bliską i — jeśli to możliwe — terapeutą. Trzy poziomy: **stabilizacja** (codzienne nawyki), **wczesne sygnały** (gdy prodromy się pojawiają), **kryzys** (pełnoobjawowy epizod, myśli samobójcze, psychoza). Każdy poziom ma: kogo poinformować, co zrobić w pierwszej kolejności, kto przejmuje konkretne odpowiedzialności. Zachowaj wydruk w widocznym miejscu i daj kopię osobie bliskiej.

DLACZEGO TO DZIAŁA

W epizodzie depresji ani manii **wgląd jest zaburzony**. W depresji nie wierzysz, że pomoc cokolwiek da. W manii nie widzisz, że jesteś chory/-a — czujesz się świetnie. Każda decyzja w epizodzie obarczona jest tym zniekształceniem. *Decyzja podjęta w eutymii* — gdy wgląd jest pełny — jest decyzją z najlepszej możliwej pozycji. Plan zapisany w spokojnym czasie ma autorytet nad chęcią „przeczekania” lub odstawienia leków. To technika znana jako *Ulysses contract* (umowa Ulissesa) — decyzja teraz na rzecz przyszłego mnie/ciebie.

01 Poziom 1 — Stabilizacja (codziennie)

Te działania utrzymują *codziennie*, niezależnie od samopoczucia. To fundament.

CO UTRZYMUJĘ

- ☐ Stałe godziny snu (różnica maks. 30 min)
- ☐ Leki o tej samej porze
- ☐ Wykres nastroju codziennie wieczorem
- ☐ Wizyty kontrolne u psychiatry: _____
- ☐ Sesje terapeutyczne: _____
- ☐ Trzy kontakty społeczne w tygodniu
- ☐ Ruch 30 min · ____ razy w tygodniu

CZEGO UNIKAM

- ☐ Alkohol — limit: _____
- ☐ Substancje psychoaktywne — całkowicie
- ☐ Praca po godzinach przekraczająca: ____ h
- ☐ Podróże przez strefy czasowe bez konsultacji
- ☐ Odstawianie leków bez psychiatry
- ☐ Inne wyzwalacze osobiste: _____
- ☐ _____

02 → Poziom 2 — Wczesne sygnały (interwencja w 48 h)

Wywołuje go: 2+ sygnały z mojej listy ostrzegawczej, sen poniżej 6 h przez 2 noce, lub osoba bliska zauważa zmianę.

CO ROBIĘ W 48 H

1. Dzwonię do psychiatry — telefon: _____
2. Informuję osobę bliską — kogo: _____
3. Wzmacniam protokół snu (8–9 h, bez kofeiny, bez alkoholu)
4. Odwołuję planowane stresory na ten tydzień
5. Notuję wykres nastroju 2× dziennie (rano i wieczorem)

03 ✕ Poziom 3 — Kryzys (natychmiast)

Wywołuje go: brak snu 2+ noce, myśli samobójcze, objawy psychotyczne (halucynacje, urojenia), niekontrolowane wydatki lub ryzykowne decyzje.

PIERWSZE 3 TELEFONY

1. Osoba bliska:

_____ · tel. _____

2. Psychiatra prowadzący:

_____ · tel. _____

3. Najbliższa izba przyjęć:

TELEFONY POMOCY

112 · pogotowie ratunkowe

116 123 · kryzysowy dla dorosłych

116 111 · kryzysowy dla dzieci i młodzieży

800 70 22 22 · centrum wsparcia

22 484 88 01 · psychologiczna pomoc 24 h

DECYZJE ZAWCZASU — WYKONUJE OSOBA BLISKA

- ☐ Przejmuje karty płatnicze i kody PIN
- ☐ Przejmuje kluczyki do auta
- ☐ Kontaktuje się z pracodawcą (wzór SMS w portfelu)
- ☐ Zabiera laptop, jeśli ryzyko impulsywnych decyzji online
- ☐ Zostaje ze mną do czasu zobaczenia lekarza
- ☐ Jeśli proponuję odstawienie leków — przypomina o tym dokumencie

04 📄 Moje dane medyczne

ROZPOZNANIE

ALERGIE I PRZECIWWSKAZANIA

LEKI (NAZWA · DAWKA · PORA)

Klucz: plan kryzysowy nie jest dokumentem na półkę — wydrukuj, podpisz datą, daj kopię osobie bliskiej i lekarzowi. *Aktualizuj co 6 miesięcy* i po każdym epizodzie. W badaniu Suppes i wsp. (2003) pacjenci ChAD z napisanym i omówionym z bliskimi planem kryzysowym mieli **o 51% mniej hospitalizacji** w 2-letniej obserwacji. Ten dokument w eutymii ma autorytet, którego nie będzie miał Twój głos w epizodzie.